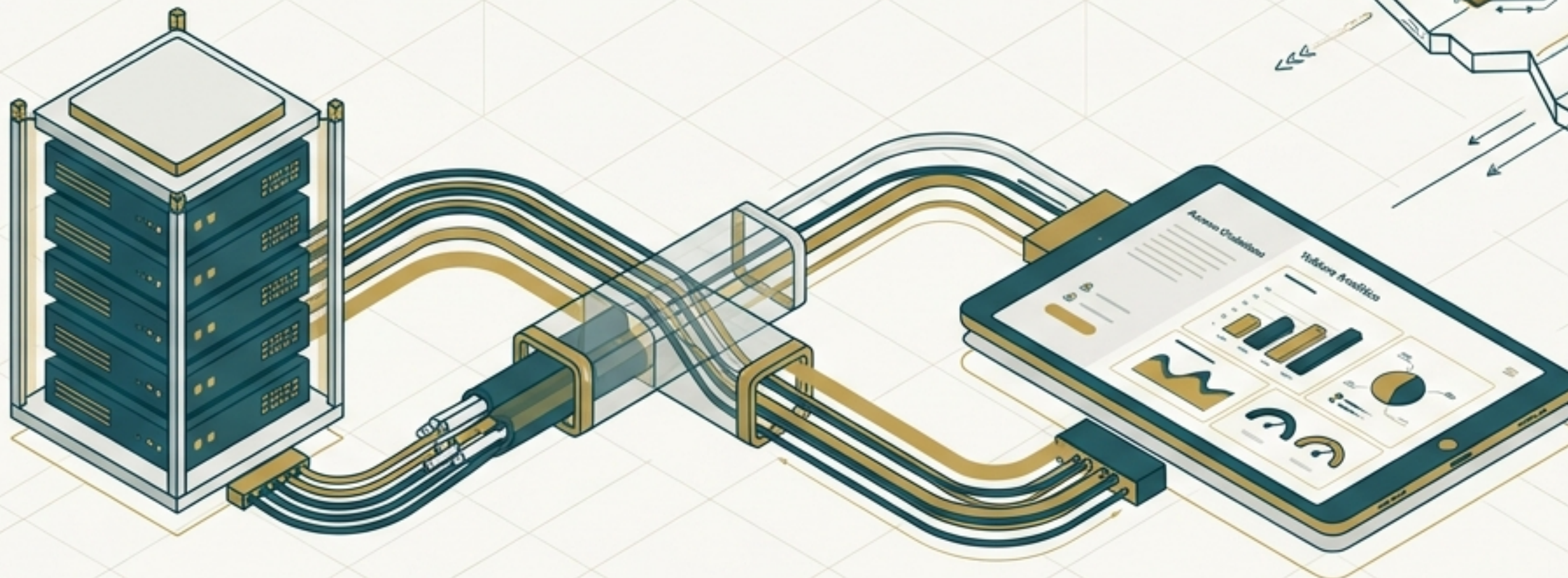


Estrategia de Datos y Analítica: Proyecto URKUNINA 5000

De la investigación clínica al
empoderamiento ciudadano.



El activo de datos es la primera base predictiva de salud pública en Nariño.

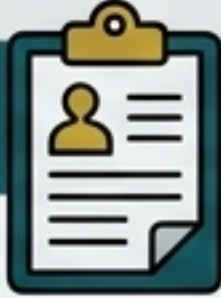
Cobertura Territorial



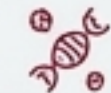
55 municipios del área andina priorizada.
100% de la meta poblacional alcanzada.



Perfiles Clínicos



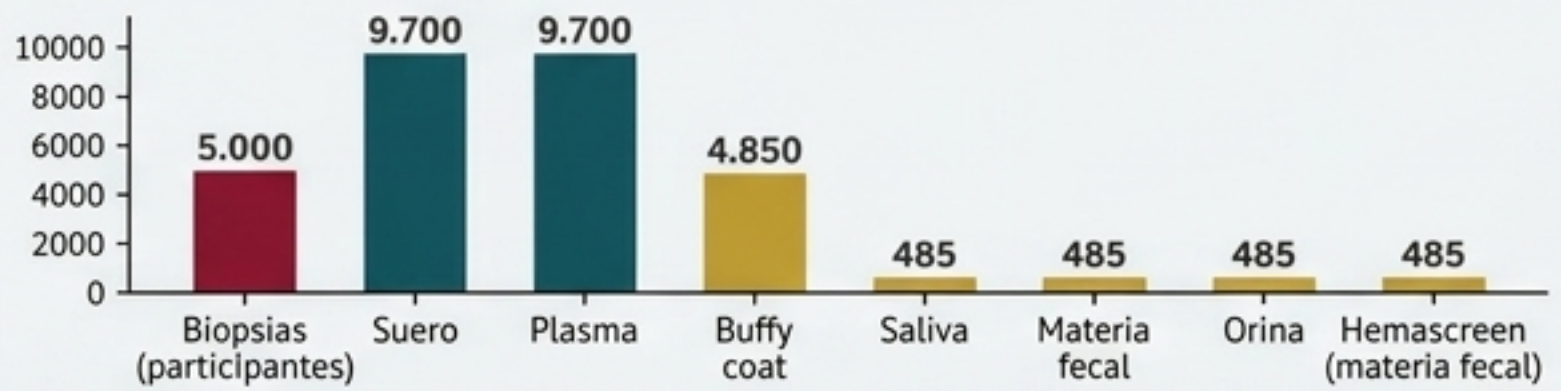
5.000 historias clínicas estandarizadas, abarcando espectros demográficos, nutricionales y patológicos.

 Demográficos  Nutritión  Patologías

Biobanco



25.000+ muestras biológicas almacenadas (suero, plasma, biopsias), listas para interoperar con bases de datos.



Impacto Real



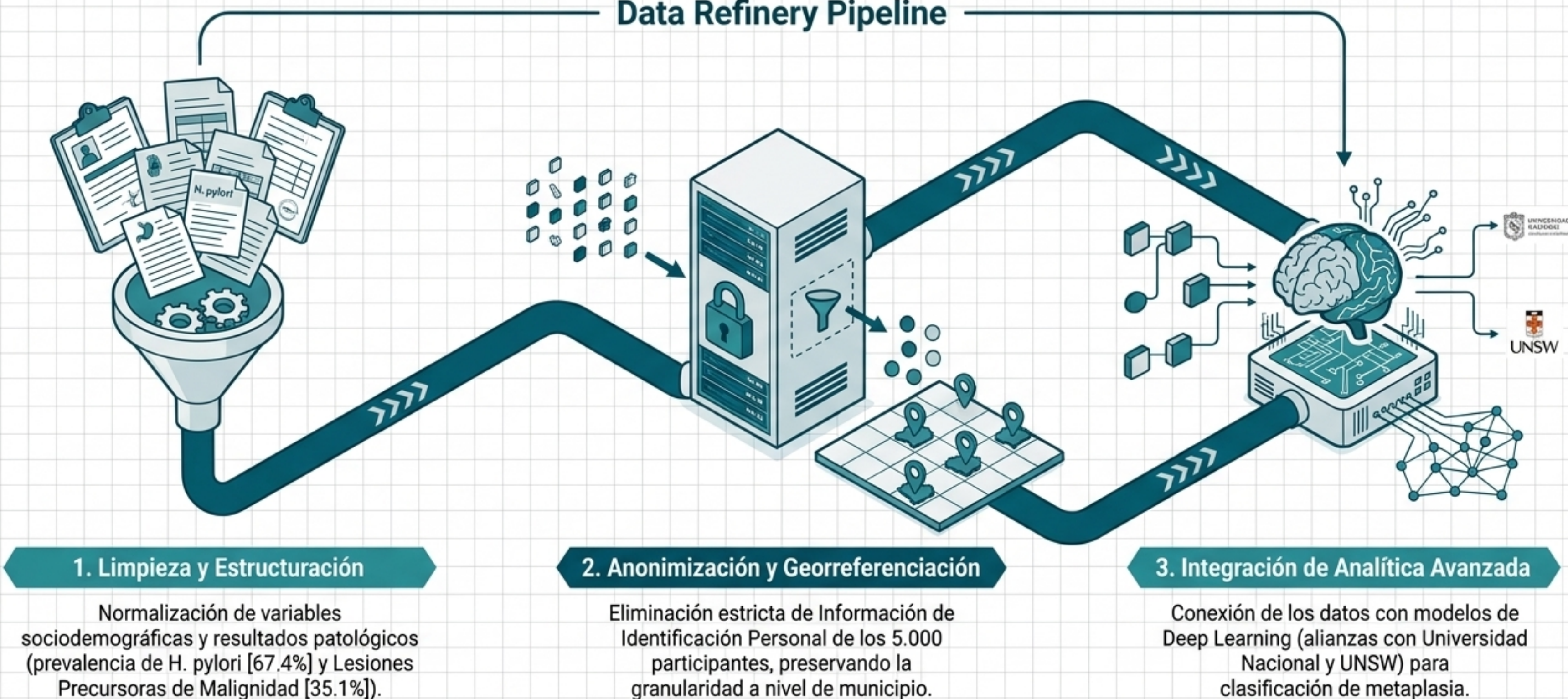
8 casos de cáncer gástrico detectados de forma temprana en **fase asintomática**.



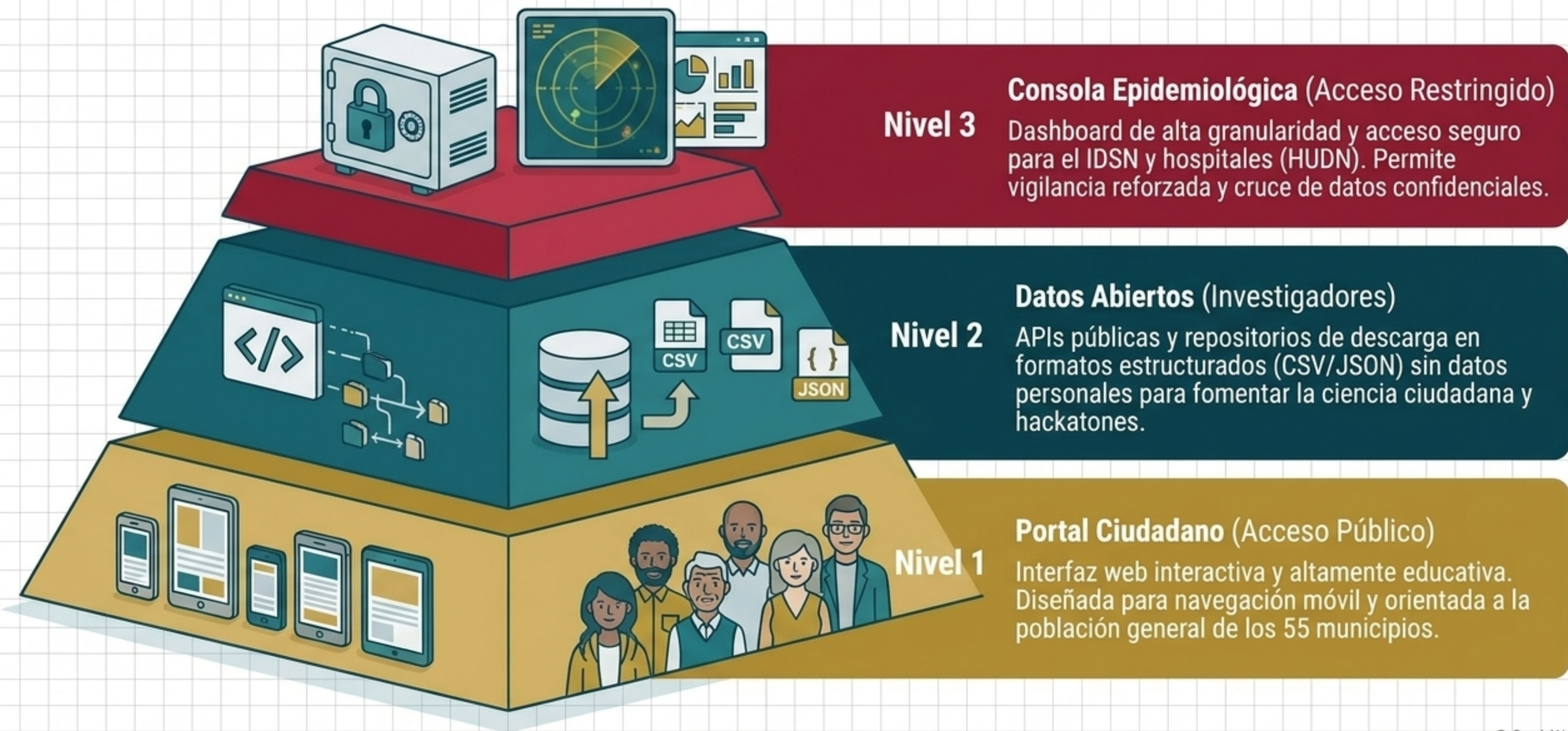
El verdadero 'por qué' de los datos.

El motor de datos procesa información clínica para convertirla en inteligencia territorial.

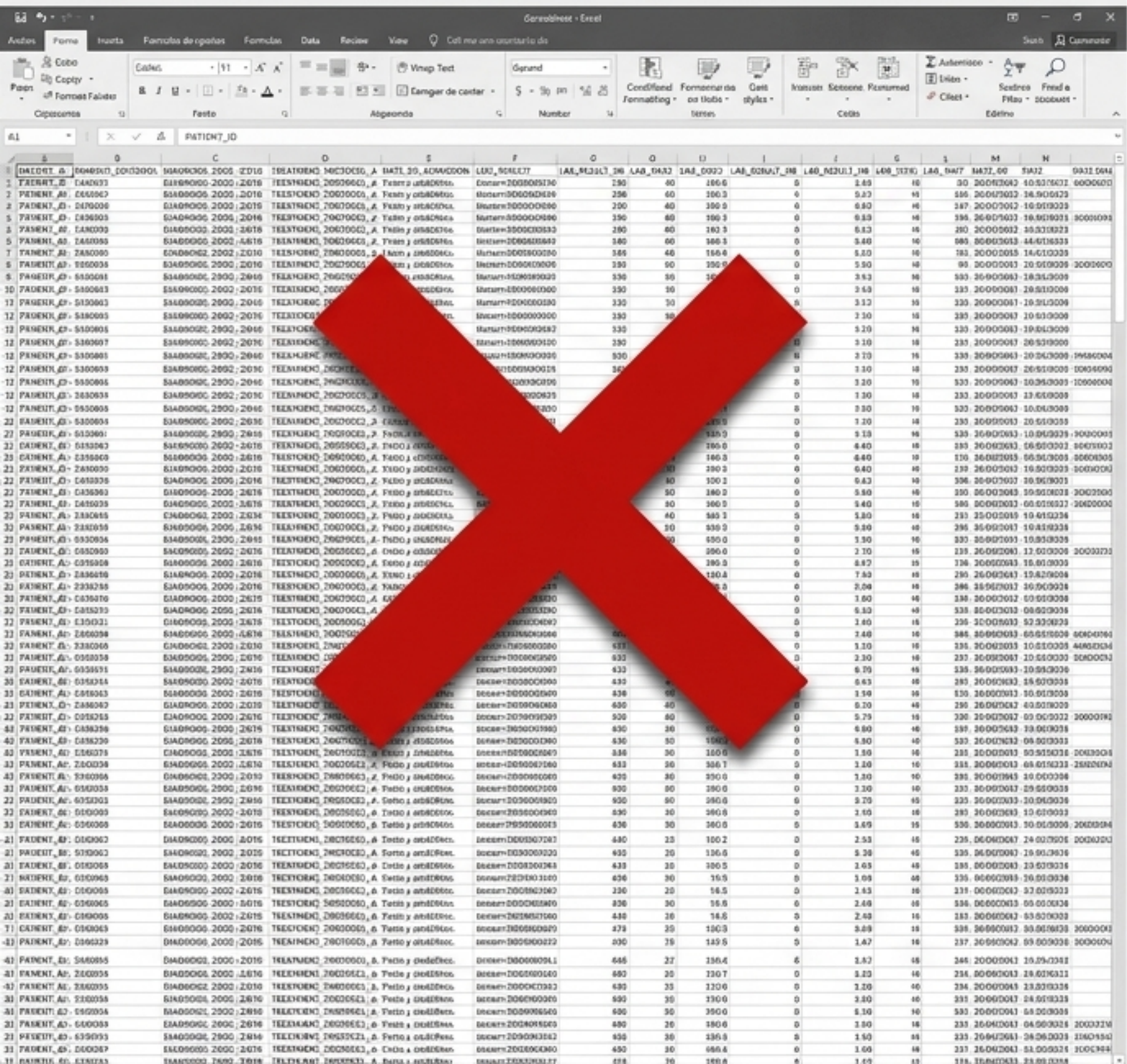
Data Refinery Pipeline



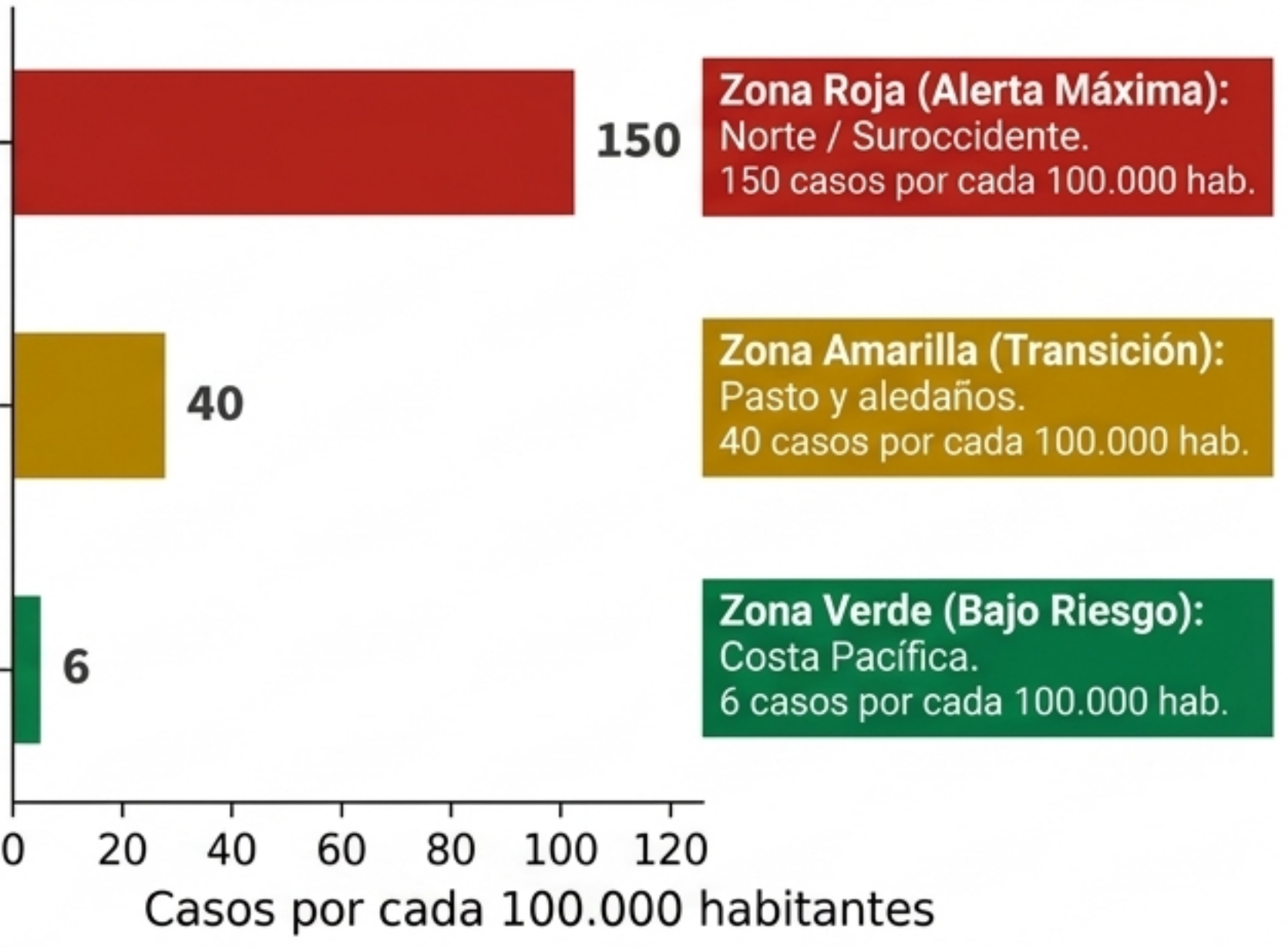
La arquitectura de publicación segmenta el acceso según el perfil del usuario.



El lenguaje visual debe contar la historia del 'Enigma Nariñense' a través del color.

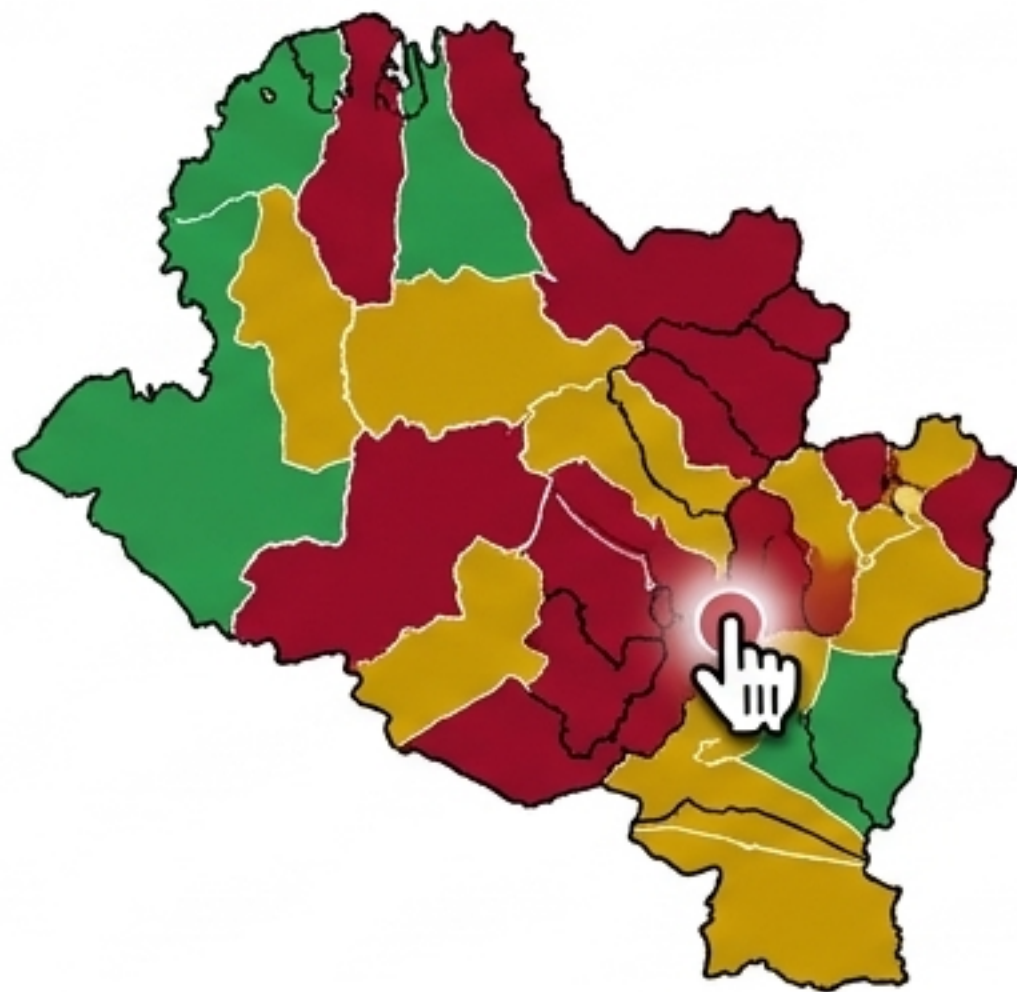


Regla Cero de Visualización:
Consistencia cromática absoluta.
El usuario debe identificar su riesgo en menos de 3 segundos.



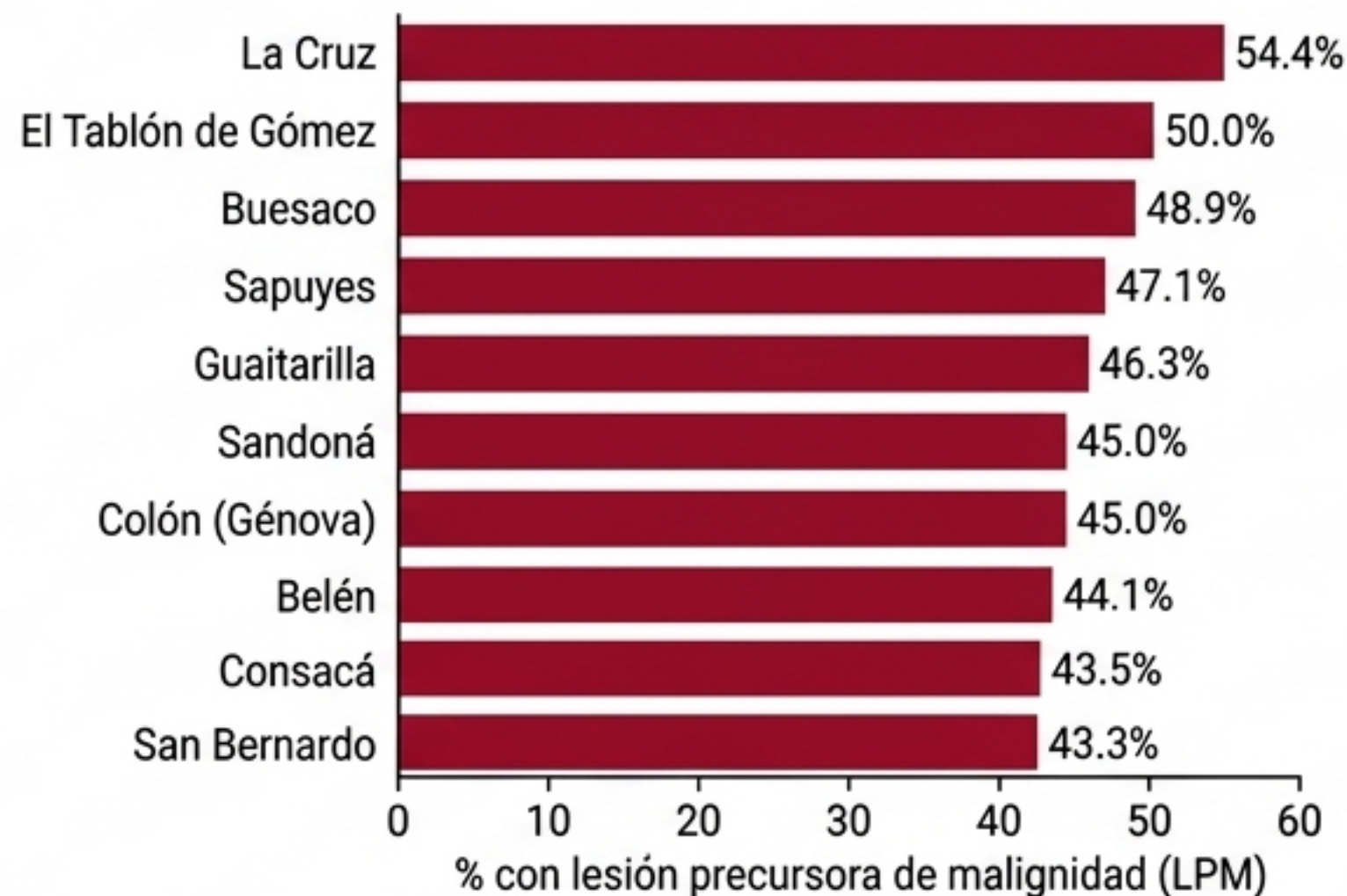
Gráficos mínimos requeridos (Parte I): La dimensión territorial del riesgo.

El Mapa Epidemiológico



Responde a la pregunta ciudadana “¿Cuál es el riesgo donde yo vivo?”. Es el ancla de navegación del portal.

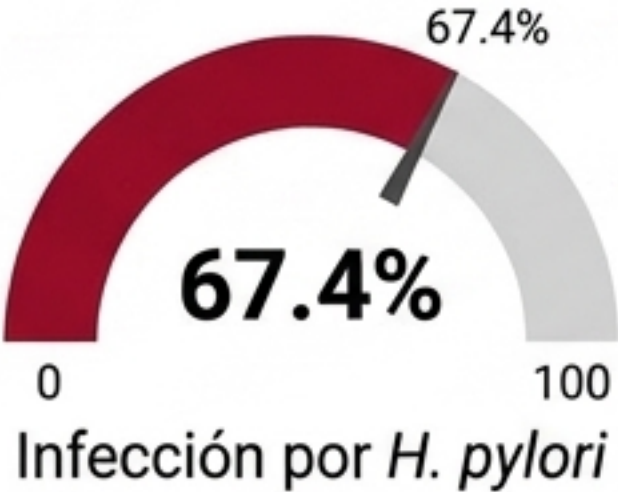
Ranking de Prevalencia (Top 10)



Permite comparativas rápidas. Las barras horizontales facilitan la lectura de nombres largos de municipios en dispositivos móviles.

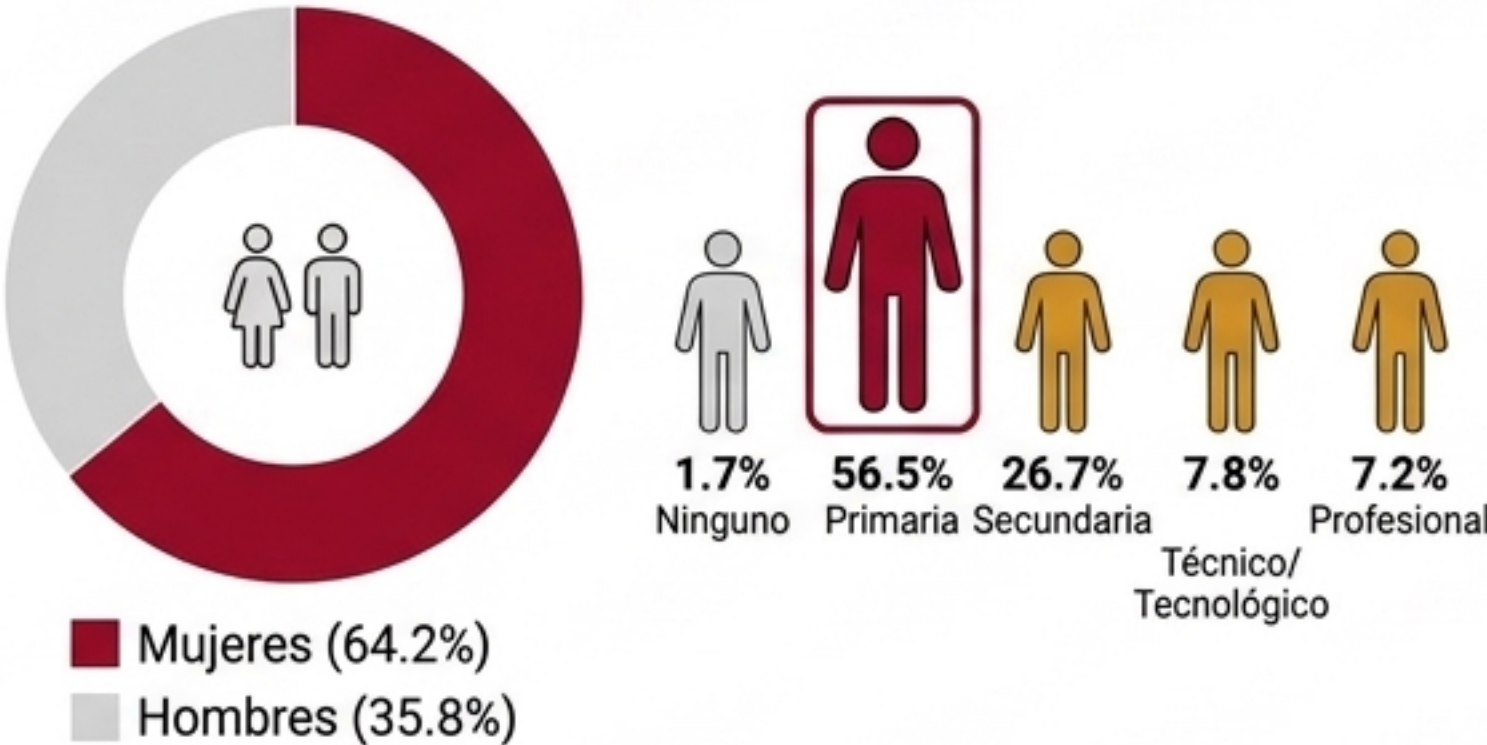
Gráficos mínimos requeridos (Parte II): La dimensión clínica y social.

Termómetros Clínicos



Comunica instantáneamente la magnitud del problema frente a la normalidad.

Perfiles Sociodemográficos



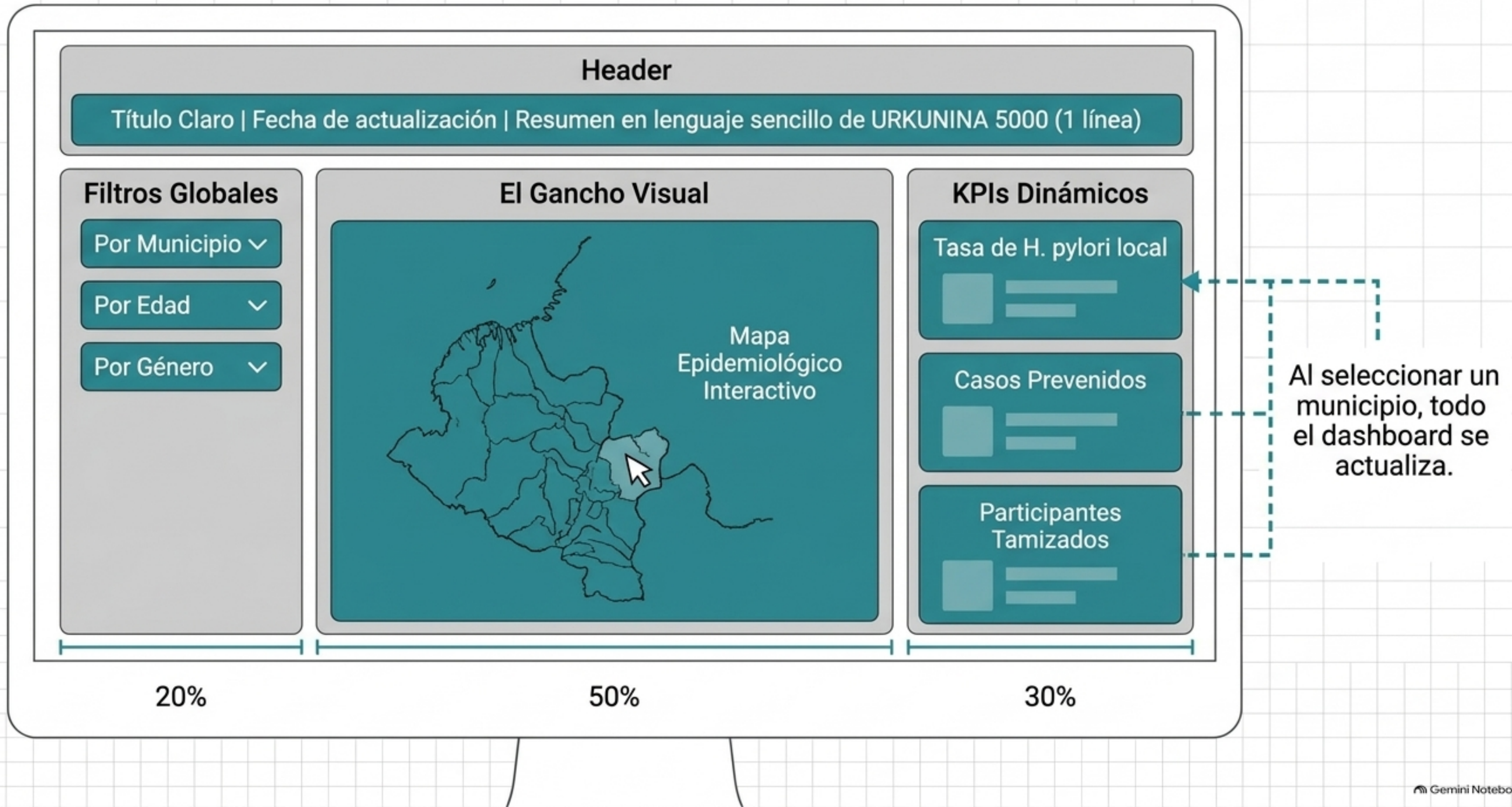
Visualiza la vulnerabilidad poblacional con un tono humano y accesible.

Traducir el rigor clínico en acciones ciudadanas claras y directas.

Jerga Clínica (El Dato)	Lenguaje Ciudadano (El Significado)	Llamado a la Acción (El Siguiente Paso)
Prevalencia de Lesión Precursora de Malignidad (LPM): 35.1%.	1 de cada 3 personas en Nariño tiene inflamación gástrica que requiere atención médica.	Participe en jornadas locales de tamizaje.
Erradicación de H. pylori como prevención primaria.	Eliminar esta bacteria común previene directamente el cáncer de estómago.	Consulte a su EPS si presenta síntomas digestivos recurrentes.

Principio Básico: Nunca presentar un dato de riesgo sin acompañarlo de una ruta de acción preventiva.

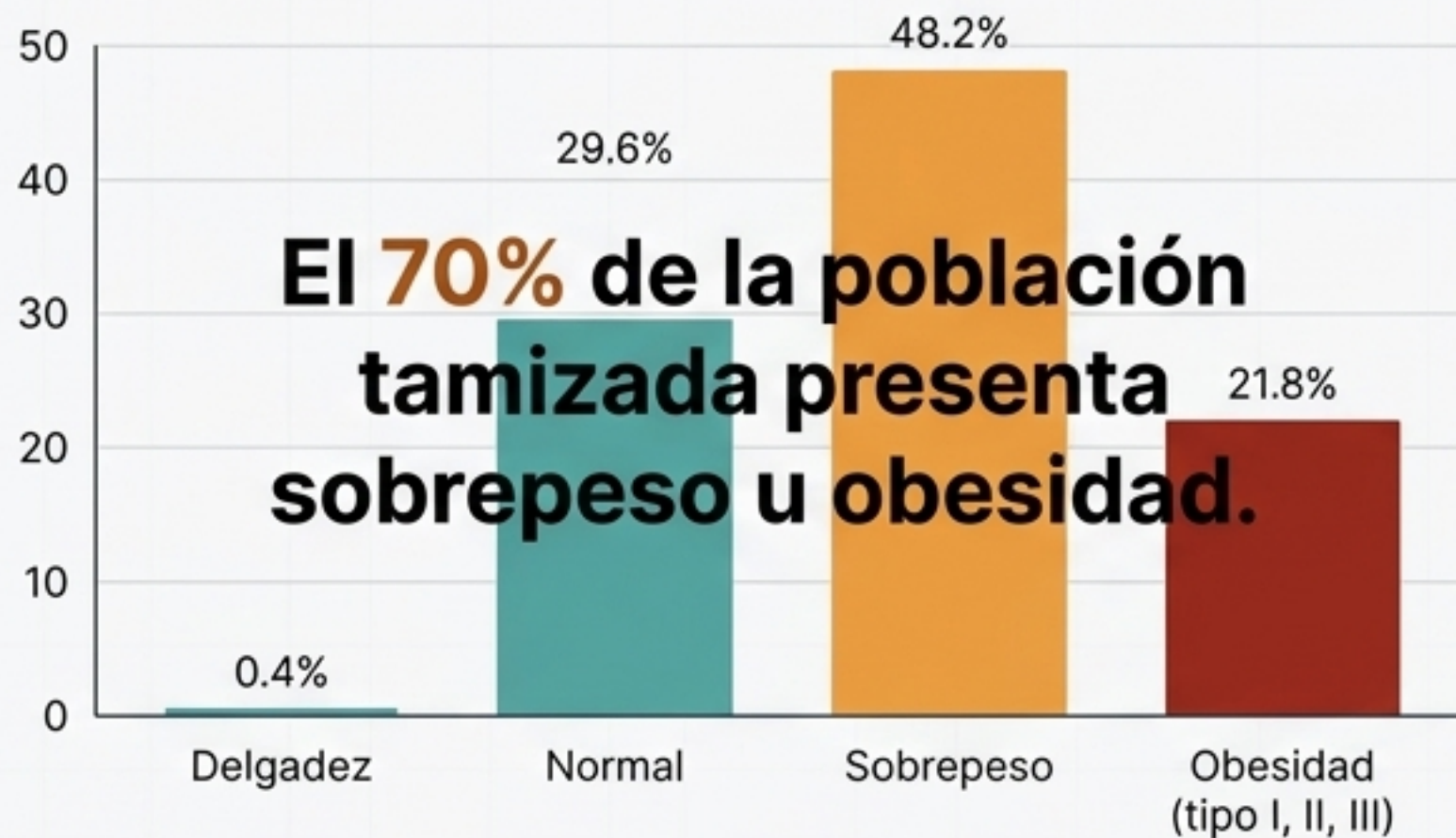
Arquitectura de la interfaz principal: El portal de consulta ciudadana.



Contexto y prevención: Elementos para un dashboard integral.

Un dashboard completo va más allá del diagnóstico estadístico.

Panel de Contexto Nutricional



Uniendo los datos clínicos con el estilo de vida.

Panel de Ruta de Atención



Síntesis: Un ecosistema vivo para la política pública y la prevención.



El objetivo no es publicar un informe estático, sino encender un faro digital permanente que salve vidas en Nariño.